

1. Introducción y relevancia clínica

La **neuritis óptica (NO)** es una **inflamación aguda del nervio óptico** que se manifiesta por **pérdida visual súbita, dolor ocular con movimientos y alteración del color (discromatopsia)**.

Se presenta con mayor frecuencia en **adultos jóvenes (20–45 años)**, especialmente mujeres, y constituye una **de las principales causas de neuropatía óptica adquirida** en este grupo.

Su importancia clínica radica en que:

- Es **la primera manifestación de esclerosis múltiple (EM)** en hasta el 20–30% de los casos.
- Es **reversible en la mayoría**, pero puede dejar **déficit visual residual**.
- Exige distinguirla de otras causas de **pérdida visual súbita indolora** (neuropatía isquémica, neuritis infecciosa, compresiva).
- En el contexto chileno, el diagnóstico oportuno permite acceso a derivación neurológica precoz y seguimiento en centros especializados.

En EUNACOM, el foco está en **identificar la tríada clásica** (pérdida visual, dolor ocular, defecto pupilar aferente), **diferenciarla de NOIA (isquémica)** y **reconocer el rol de los corticoides y la RM cerebral** en manejo.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Anatomía funcional

El **nervio óptico (NO)** es una extensión del sistema nervioso central (SNC), recubierto por meninges y mielinizado por **oligodendrocitos**.

Se divide en 4 segmentos:

1. **Intraocular (papila óptica).**
2. **Intraorbitaria.**

3. Intracanalicular.

4. Intracraneal.

Su irrigación proviene de las arterias ciliares posteriores cortas y ramas de la arteria central de la retina.

Su lesión interrumpe la transmisión de impulsos visuales desde la retina al quiasma.

2.2 Mecanismo fisiopatológico

En la neuritis óptica, ocurre una **desmielinización inflamatoria** del nervio, mediada por linfocitos T y anticuerpos dirigidos contra la mielina.

- Esto reduce la **conducción axonal** y genera **bloqueo visual agudo**.
 - En fases avanzadas, puede producir **degeneración axonal y atrofia óptica**.
-

2.3 Etiología

Grupo etiológico	Causas principales
Desmielinizantes (más frecuentes)	- Esclerosis múltiple (EM) . - Neuromielitis óptica (NMO, enfermedad de Devic) – anticuerpo AQP4-IgG . - MOGAD (anticuerpo contra MOG).
Infecciosas	Sífilis, Lyme, tuberculosis, virus (herpes, VIH), toxoplasmosis.
Inflamatorias / autoinmunes	Sarcoidosis, lupus, vasculitis, Behçet.
Postinfecciosas o vacunales	Secundarias a infecciones respiratorias o vacunas (mecanismo autoinmune).

Tóxicas / carenciales Etambutol, metanol, cloranfenicol, deficiencia B12 (no estrictamente neuritis, pero neuropatía).

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas cardinales

1. **Pérdida visual súbita (horas–días):**
 - Habitualmente unilateral.
 - Máxima pérdida en 2–7 días.
 - Rango: leve a amaurosis completa.
 - Recuperación espontánea en semanas.
 2. **Dolor ocular, especialmente con movimientos** (en 90% de los casos).
 - Por inflamación del segmento retrobulbar del NO.
 3. **Discromatopsia (alteración en la percepción de colores)**
 - Disminución precoz para el rojo.
 4. **Fenómeno de Uhthoff:**
 - Empeoramiento visual transitorio con el calor (baño caliente, fiebre).
 5. **Fenómeno de Pulfrich:**
 - Percepción alterada de profundidad en visión binocular.
-

3.2 Signos clínicos

Hallazgo

Descripción

Comentario

Defecto pupilar aferente relativo (DPAR o pupila de Marcus Gunn)	Pupila afectada se contrae menos ante luz directa, pero sí con luz en el ojo sano.	Signo más confiable de lesión del nervio óptico unilateral.
Fondo de ojo normal	En 2/3 de casos (neuritis retrobulbar).	“El paciente no ve, y el médico no ve nada”.
Papilitis (edema del disco óptico)	En 1/3 de casos (neuritis anterior).	Borramiento de bordes, leve hiperemia.
Disminución agudeza visual y visión de colores.	Puede llegar a 20/200 o peor.	Mejora en semanas.

3.3 Diagnóstico diferencial

Entidad	Claves distintivas
Neuropatía óptica isquémica anterior (NOIA)	>50 años, sin dolor, fondo con papila edematosa pálida, factores vasculares (HTA, DM).
Neuritis infecciosa	Fiebre, inflamación sistémica, fondo de ojo con exudados.
Neuromielitis óptica (NMO)	Bilateral, severa, sin recuperación espontánea, RM normal o con lesión extensa.
Toxicidad por etambutol / metanol	Bilateral, progresiva, sin dolor, discromatopsia rojo-verde.
Compresión tumoral del NO	Curso crónico progresivo, sin dolor.

Papiledema

Bilateral, asociado a hipertensión intracraneal; visión central preservada inicialmente.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 En atención primaria (APS)

- **Agudeza visual** (Snellen).
- **Visión de colores** (test de Ishihara).
- **Reflejos pupilares** → detectar DPAR.
- **Fondo de ojo:**
 - Normal (neuritis retrobulbar).
 - Edema leve del disco (papilitis).
- **Derivación urgente a oftalmología/neuro-oftalmología.**

Criterio clave: pérdida visual aguda, dolor ocular y DPAR → sospecha de neuritis óptica.

4.2 En especialidad (Oftalmología/Neurología)

Examen	Utilidad
Campimetría computarizada (Humphrey)	Detecta escotomas centrales o cecocentrales.
OCT de capa de fibras nerviosas (RNFL)	Mide daño axonal. Disminuye tras 4–6 semanas.
Resonancia magnética de cerebro y órbitas (con gadolinio)	Determina desmielinización y riesgo de EM. Lesiones periventriculares aumentan riesgo a 50–70%.

Potenciales evocados visuales (PEV)	Latencia aumentada, amplitud disminuida (desmielinización).
Laboratorios dirigidos	VDRL, VIH, Lyme, B12, ANCA, sarcoidosis según contexto.

4.3 Criterios diagnósticos clínicos

Diagnóstico clínico de neuritis óptica idiopática típica (criterios AAO):

1. Pérdida visual subaguda unilateral (días).
 2. Dolor ocular con movimientos.
 3. DPAR positivo.
 4. Fondo de ojo normal o con leve edema.
 5. Ausencia de signos inflamatorios intraoculares o sistémicos.
 6. Recuperación parcial en 2–6 semanas.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / SOCHIOF / AAO)

5.1 Manejo inicial

- Derivación urgente a oftalmología y neurología.
- Excluir causas secundarias (infección, tóxico, NMO).
- Indicar **RM cerebral con gadolinio**.

5.2 Tratamiento farmacológico

Medicamento	Esquema	Objetivo
-------------	---------	----------

Metilprednisolona EV	250 mg cada 6 h por 3 días (total 1 g/día)	Disminuye inflamación y acelera recuperación visual (ONTT).
Prednisona VO	1 mg/kg/día por 11 días luego reducción progresiva.	Mantenición corta.
Evitar corticoides VO solos	Sin dosis EV previa → aumenta riesgo de recurrencia.	

Evidencia (ONTT, Optic Neuritis Treatment Trial):

- Corticoides EV aceleran la recuperación, **no cambian el resultado visual final**.
- Prednisona oral aislada aumenta recurrencia → **no usar sola**.

5.3 En casos especiales

- **NMO o MOGAD:**
 - Corticoides + inmunosupresores (azatioprina, rituximab, micofenolato).
 - Plasmaféresis si severa o refractaria.
- **Neuritis infecciosa:**
 - Tratar la causa (p. ej., penicilina en sífilis).
- **Tóxica o carencial:**
 - Suspender agente, suplementar B12.

5.4 Seguimiento

- Evaluación visual cada 2 semanas durante el primer mes, luego mensual hasta estabilización.

- RM de control a 3–6 meses en sospecha de EM.
- Si aparecen nuevas lesiones o brotes → manejo como **esclerosis múltiple** con neuromoduladores (interferón β , natalizumab, ocrelizumab).

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción	Comentario
Atrofia óptica secundaria	Palidez del disco 4–8 semanas post evento.	Irreversible.
Recurrencias	30% en 10 años; más si lesiones desmielinizantes en RM.	Mayor riesgo en mujeres jóvenes.
Evolución a esclerosis múltiple (EM)	50% en 15 años (si lesiones periventriculares).	Requiere manejo neurológico.
Pérdida visual permanente	En casos severos, NMO, o retraso diagnóstico.	Pronóstico peor en bilateral.

Pronóstico visual:

- 90% recupera >20/40 en 6 meses (neuritis idiopática típica).
- Peor pronóstico si: NMO, bilateralidad, ausencia de dolor, mala visión inicial (<20/200).

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Neuritis óptica típica:** mujer joven + dolor ocular + pérdida visual subaguda unilateral.
 2. **DPAR** (Marcus Gunn) = signo clínico más sensible.
 3. Fondo de ojo normal no descarta → **neuritis retrobulbar**.
 4. **RM cerebral con gadolinio** predice riesgo de **esclerosis múltiple**.
 5. **Corticoides EV** aceleran recuperación; **VO** solos **contraindicados**.
 6. **Recuperación espontánea** habitual, pero monitorizar riesgo neurológico.
 7. Ante bilateralidad o mal pronóstico → pensar en **NMO o MOGAD**.
-

Errores comunes

- No derivar a **neurología** tras diagnóstico.
 - Indicar **prednisona oral sin dosis EV previa**.
 - Confundir con **NOIA (isquémica)** → población y clínica distintas.
 - No solicitar **RM cerebral** en paciente joven con primera neuritis.
 - Omitir búsqueda de causas infecciosas o tóxicas.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **neuritis óptica** es una inflamación aguda del nervio óptico, causa frecuente de **pérdida visual súbita en adultos jóvenes**.
2. Triada típica: **pérdida visual + dolor ocular con movimientos + DPAR**.
3. Puede ser la **primera manifestación de esclerosis múltiple**.
4. **Fondo de ojo normal en 2/3** (neuritis retrobulbar).
5. **Tratamiento: metilprednisolona EV 3 días + prednisona VO corta**.

6. **No usar corticoides orales solos** → aumenta riesgo de recurrencia.
7. **Pronóstico visual favorable** en la mayoría, pero requiere **seguimiento neurológico**.